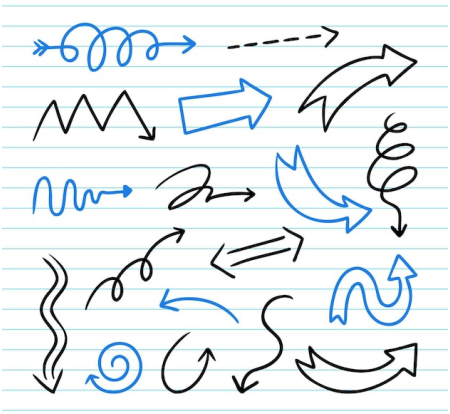


# TEMA 32



ESQUEMA DEL TEMA

LA SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MADRID, MADRID SALUD:

COMPETENCIAS, RED DE CENTROS Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN.

PAPEL DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN LAS INTERVENCIONES DE SALUD COMUNITARIA.

# INTRODUCCIÓN

**SALUD PÚBLICA:** Ejercer y mantener la salud de la población, así como control o erradicación de la enfermedad.

**Conceptos claves en salud pública:**

| | |
|---|---|
| **Protección sanitaria.** | Control sanitario del medio ambiente (contaminación del suelo, agua, aire ...) → Detección de factores de riesgo para la población. |
| **Promoción sanitaria.** | Fomento de la salud de individuos y comunidades → Adopción de estilos de vida saludables / educación sanitaria + cambios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas. |
| **Prevención epidemiológica.** | Prevención primaria (vacunaciones) / Prevención secundaria (detección precoz de enfermedades) / Prevención terciaria (contención o rehabilitación de las secuelas). |

**Importancia de los determinantes de la salud:**

| | |
|---|---|
| **Estilo de vida.** | Es el determinante más influyente en la promoción de la salud. |
| **Biología humana.** | Se refiere a la herencia genética. Difícilmente modificable. |
| **Sistema sanitario.** | Supone un gasto importante en recursos económicos. |
| **Medio ambiente.** | Contaminación, medio ambiente psicosocial y sociocultural. |

**Documentos Internacionales sobre salud pública:**

| | |
|---|---|
| **Carta de Otawa, 1.986** | Promoción de la salud como estrategia fundamental para aumentar la salud de la población. |
| **Estrategia Salud 21.** | Promover y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida y reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como el sufrimiento que originan.<br>Fundamentos éticos: salud como derecho fundamental / equidad y solidaridad en todos los países / participación y responsabilidad de personas, grupos, instituciones y comunidades. |

# 1.- MARCO LEGISLATIVO EN SALUD PÚBLICA.

| **Constitución.** | **Ley 7/1.985.** | **Ley 14/1.986.** |
|---|---|---|
| . Art. 43: derecho a la salud.<br>. Art. 148.1.21 (CC.AA.): sanidad e higiene.<br>. Art. 149.1.16 (Estado): sanidad exterior, bases/coordinación sanitaria / legislación farmacéutica. | Competencias de la Adm Local:<br>. 25.2.j.: salubridad pública.<br>. 25.2.k.: cementerios y actividades funerarias. | Atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud:<br>. Atención primaria,<br>. Atención especializada.<br>. Atención farmacéutica. |

## 2.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.

**Estatuto de Autonomía de la CM. L.O. 3/1.983.**

. Art. 27.4. Sanidad e higiene.

. Art. 27.5. Coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social.

**Real Decreto 1.479/2.001.**

Traspaso a la CM de las funciones y servicios sanitarios del Insalud.

**LOSCAM. Ley de Ordenación Sanitaria de la CM. Ley 12/2.001, de 12 de diciembre.**

**Título VI. Salud Pública.**

Competencias en la Consejería de Sanidad: DG de Salud Pública.

. Funciones: análisis de los determinantes salud-enfermedad / inspección en salud pública (control cadena alimentaria) / sanidad mortuoria / elaboración del informe de Estado de Salud / educación sanitaria de la población / vigilancia epidemiológica / programas de prevención de enfermedades / medio ambiente / promoción y mejora de la salud laboral / mejora de la formación del personal / colaboración con el sector privado.

. Funciones de las Corporaciones Locales (art. 18) → control sanitario y salubridad.

- (art. 137): Servicios mínimos obligatorios del régimen municipal / Control sanitario del medio ambiente / Control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes / Control sanitario de edificios y viviendas / Control sanitario de alimentos y bebidas / Control sanitario de cementerios y política sanitaria mortuoria / Promoción de la salud, educación sanitaria y protección de grupos con riesgos específicos / educación sanitaria, vivienda, protección del medio y fomento del deporte.

## 3.- MADRID SALUD: COMPETENCIAS, RED DE CENTROS Y SERVICIOS.

**ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "MADRID SALUD".**

**19 de noviembre de 2.004 → Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud** (AG de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias) → Política municipal en Salud Pública y Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

| | |
|---|---|
| **Salud Pública.**<br>**Instituto de Salud Pública.** | Promoción de la salud, prevención de enfermedades, calidad y seguridad alimentaria, salud ambiental, control zoosanitario, sanidad mortuoria, evaluación de actuaciones, inspección sanitaria, formación e investigación. |
| **Drogodependencias.**<br>**Instituto de Adicciones.** | Asistencia, prevención, reinserción y evaluación, formación e investigación en adicciones. |

**Funciones:** Salud Pública y Drogodependencias / Actividades preventivas, sanitarias y asistenciales / Prevención y promoción de la salud y hábitos saludables / Inspección sanitaria de las Juntas de Distrito / Elaboración del Plan Anual de Inspección / Salud Pública en las Juntas de Distrito / Calidad y seguridad alimentaria / Inspección de establecimientos y empresas (seguridad alimentaria y salud ambiental) /Información, formación, apoyo y asesoramiento en drogodependencias / Formación / Información y asesoramiento a las Juntas de Distrito / Potestad sancionadora en salud pública / Sanidad mortuoria / Control zoosanitario / Vigilancia en Salud Pública / Salud ambiental / Actividades preventivas, asistenciales e integradoras / Escuela de Salud Pública / Inspección sanitaria de Mercamadrid / Dirección de la Oficina de Salud / Recursos de asistencia y/o reinserción de pacientes drogodependientes / Competencias locales en adicciones (Ley 5/2.002) / Coordinación / Análisis y sistematización de la información / Firma de Convenios / Concesión de subvenciones / Eventos y actividades / Coordinación y redes institucionales / Protección animal / Potestad sancionadora en protección de animales domésticos / Protección y bienestar animal / Inspección animales de compañía / Control de poblaciones animales.

| | |
|---|---|
| **Cartas de Servicios de Madrid Salud.** | . CS de Calidad del Agua de consumo de grifo (2.018).<br>. CS de Habitabilidad y Salubridad de la vivienda (2.011).<br>. CS de Servicios de actuaciones urgentes ante brotes y alertas alimentarias (2.010).<br>. CS de Prevención y control de plagas (2.014).<br>. CS de Salud Laboral (2.011).<br>. CS del Centro de prevención del deterioro cognitivo (2.016).<br>. CS del Consejo Sanitario en Viajes y Vacunación Internacional (2.015).<br>. CS del Instituto de Adicciones (2.007).<br>. CS del Laboratorio Municipal de Salud Pública (2.022). |

**ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA.**

Protección de la salubridad pública → Seguridad Alimentaria / Salud Ambiental y Control de Vectores y Plagas / Promoción de la Salud y bienestar animal.

**PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.**

**Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc).** Centros municipales especializados en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades / Plantillas multidisciplinares + **Centros monográficos especializados.**

- **Actuaciones de los CMSc**: promoción estilos de vida saludables / educación para la salud / Actividades preventivas / Malestares de la vida cotidiana / Refuerzo de la comunidad / Eliminación de barreras / Atención a zonas y grupos con mayores necesidades en salud / Espacios de encuentro y redes en los distritos / Apoyo al cuidado individual y colectivo.
- **Intervenciones**: Atención individual / Atención grupal / Actividades comunitarias.
- Atienden a cualquier persona, organizaciones, asociaciones, colectivos …

**PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

**Ley 31/1.995** → Prevención de riesgos profesionales, protección de la seguridad y la salud, eliminación de riesgos en el trabajo, información, consulta, participación equilibrada de los trabajadores y formación en materia preventiva → Evaluación de riesgos en personas y edificios / Vigilancia de la salud de los empleados.

**Funciones:** Plan de prevención de riesgos laborales / Evaluación de factores de riesgo / Planificación actividad preventiva / Información y formación de los trabajadores / Primeros auxilios y planes de emergencia / Vigilancia de la salud / Reconocimientos médicos a la mujer / Reconocimientos médicos para la adaptación de puestos de trabajo / Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral.

. Se desarrolla a través del Instituto Fabiola de Mora y Aragón.

## 4.- ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: MADRID, UNA CIUDAD SALUDABLE, 2.021-2.024.

**Conjunto de actuaciones municipales orientadas a prevenir la enfermedad y promocionar la salud en la ciudad de Madrid → Prevención y promoción de la salud comunitaria → Aumento de la capacidad de las personas y de las comunidades para incrementar su control sobre los determinantes de la salud.**

**19 de noviembre de 2.004 → Estatutos del Organismo Autónomo Madrid Salud** (AG de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias) → Política municipal en Salud Pública y Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

| | |
|---|---|
| **Salud Pública.**<br>**Instituto de Salud Pública.** | Promoción de la salud, prevención de enfermedades, calidad y seguridad alimentaria, salud ambiental, control zoosanitario, sanidad mortuoria, evaluación de actuaciones, inspección sanitaria, formación e investigación. |
| **Drogodependencias.**<br>**Instituto de Adicciones.** | Asistencia, prevención, reinserción y evaluación, formación e investigación en adicciones. |

**Misión y visión de la Estrategia Madrid, una Ciudad Saludable.**

| | |
|---|---|
| **Misión.** | . Actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad promoviendo la participación de las personas para aumentar su autonomía y corresponsabilidad en la salud.<br>. Creación de una red de centros de referencia y liderazgo en espacios de encuentro y coordinación intersectorial en salud.<br>. Creación de una red sólida con las redes sociales del distrito y cohesión de los barrios para afrontar crisis sanitarias. |
| **Visión.** | Promoción de un alto nivel de salud y bienestar potenciando su participación y corresponsabilidad en la consecución de esta situación. |

| **Principios rectores y criterios metodológicos.** | |
|---|---|
| **Principios rectores.** | . Equidad en salud.<br>. Universalismo proporcional.<br>. Intersectorialidad.<br>. Enfoque integral y ecológico.<br>. Participación.<br>. Compromiso ético. |
| **Criterios metodológicos.** | . Orientación comunitaria.<br>. Atención a los determinantes sociales de salud.<br>. Enfoque salutogénico.<br>. Mapeo de actividades en salud.<br>. El trabajo en equipo, interprofesional e interdisciplinar.<br>. Eliminación de las barreras sociales y culturales.<br>. Intervención individual y grupal.<br>. Proyectos de Centro.<br>. Evidencia.<br>. Evaluación. |
| **OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS OPERATIVOS.** | |
| **Objetivos generales.** | . Promover la salud y prevención de los principales problemas de salud → detección precoz. Intervención individual, grupal y salud comunitaria.<br>. Promoción de la salud como factor relevante en las políticas municipales. |
| **Objetivos operativos.** | . Mejora de las condiciones de salud → asesoría en salud pública y promoción de la salud.<br>. Red para prevención de la soledad no deseada y del duelo complicado.<br>. Equidad en salud en Madrid → participación de la población, especialmente de colectivos en vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.<br>. Hábitos saludables → alimentación sana y actividad física regular.<br>. Vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades.<br>. Disminución de la prevalencia y fomento del abandono del consumo de tabaco.<br>. Salud mental y bienestar emocional → potenciación de las capacidades de las personas y del entorno.<br>. Desarrollo adecuado de los menores en la crianza.<br>. Apoyo a la comunidad escolar → prevención y promoción de la salud.<br>. Ampliación de la esperanza de vida activa y saludable / Retraso de la discapacidad y la dependencia. |

**LÍNEAS DE ACTUACIÓN.**

**Línea principal: orientación en salud pública**

- **Proyectos estratégicos:** atención a las nuevas necesidades detectadas.
- **Programas marco:** abordaje de problemas y oportunidades de salud tradicionalmente prioritarios.

| | |
|---|---|
| **Programas transversales.** | . Desigualdades en salud.<br>. Promoción de la salud mental. |
| **Programas a áreas concretas.** | . Alimentación y actividad física.<br>. Prevención del tabaquismo.<br>. Salud sexual y reproductiva. |
| **Programas para ciclos vitales.** | . Maltrato infantil.<br>. Ámbito educativo.<br>. Envejecimiento activo y saludable. |

- **Proyectos de centro:** definición de las prioridades establecidas por cada CMSc.

**LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ACTUAL ESTRATEGIA**

| | | |
|---|---|---|
| Pandemia. | Asesoría en salud pública. | **ORIENTACIÓN EN SALUD PÚBLICA EN TODAS LAS ACTUACIONES.** |
| Personas solas. | Redes de apoyo para personas en soledad no deseada. | **PROYECTO ESTRATÉGICO DE SOLEDAD NO DESEADA / COMUNIDADES COMPASIVAS.** |
| Sedentarismo / Malos hábitos alimentarios. | Alimentación sana y actividad física regular. | **PROGRAMA MARCO ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (ALAS).** |
| Ascenso infecciones ginecológicas. | Vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades. | **PROGRAMA MARCO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.** |
| Población consumidora de tabaco. | Disminución de la prevalencia del consumo de tabaco. | **PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO.** |
| Porcentaje hogares monomarentales. | Salud de padres/madres, embarazadas, bebés y entorno socio-familiar. | **PROGRAMA MARCO SALUD MATERNO INFANTIL.** |
| Mayores en riesgo. | Esperanza de vida activa y saludable / Retraso discapacidad y dependencia. | **PROGRAMA MARCO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.** |
| Menores con sobrepeso. | Prevención y promoción de la salud en el ámbito educativo / Coordinación recursos socio-sanitarios y educativos. | **PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.** |

| | | |
|---|---|---|
| Personas con riesgo de problemas de salud mental. | Promoción de la salud mental y el bienestar emocional. | **PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL.** |
| Tasas de riesgo de pobreza. | Equidad de salud en Madrid / participación de la población (personas y colectivos en vulnerabilidad, exclusión o pobreza). | **PROGRAMA MARCO DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.** |
| Problemas de salud en un territorio concreto. | Adaptación de las actuaciones a un territorio específico. | **PROYECTOS DE CENTRO.** |

## DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA MADRID, UNA CIUDAD SALUDABLE.

**ORIENTACIÓN EN SALUD PÚBLICA.**

Ser referencia en la prevención y promoción de la salud, especialmente en situaciones de crisis epidemiológicas.

- Prevenir y romper las cadenas de contagios.
- Atender las necesidades de salud provocadas por las crisis sanitarias.
- Mantener la atención a las necesidades habituales de salud.

**PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA.**

Riesgos en la salud física y psíquica originados por la ausencia de vínculos personales, especialmente entre las personas mayores. El proyecto se basa en actuaciones orientadas a facilitar el encuentro y la creación de vínculos interpersonales en los barrios.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Fomentar una sociedad en red donde las personas se vinculen y se favorezca la sociedad y el bienestar. |
| **Objetivos específicos.** | . Sensibilizar a la ciudadanía / promover actitudes empáticas y de corresponsabilidad.<br>. Fortalecer la capacidad de los centros para el encuentro interpersonal → colaborar con colectivos sociales, favorecer actuaciones grupales y comunitarias, desarrollar actuaciones de encuentro por recursos públicos y privados, generar canales de vinculación.<br>. Desarrollar itinerarios de actuación para los diferentes territorios y situaciones de riesgo. |

**Comunidades Compasivas.** Fortalecer la capacidad de las personas de afrontar situaciones de duelo → crear una red de solidaridad y apoyo a personas en situación final de la vida o por la pérdida de un ser querido.

**PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.**

La organización y estructura social de una población genera desigualdades. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en que las personas viven. Son diferencias injustas y evitables. El programa incorpora la equidad en salud para contribuir a disminuir las desigualdades.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Contribuir a la equidad en salud en la ciudad de Madrid → Atención a los determinantes de la salud aplicando el universalismo proporcional. |
| **Objetivos específicos.** | . Incorporación de la perspectiva de equidad en salud.<br>. Incorporación del enfoque de universalismo proporcional en todos los programas marco.<br>. Favorecer sinergias con nuevas alianzas.<br>. Fomento de la participación comunitaria y el empoderamiento de la ciudadanía.<br>. Acceso a los servicios y a los recursos.<br>. Aplicación de la perspectiva de género.<br>. Apoyo a las estrategias de prevención de la soledad no deseada.<br>. Sensibilización, conocimiento e investigación sobre las desigualdades sociales. |

**PROGRAMA MARCO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (ALAS).**

Las circunstancias sociales y culturales determinan los estilos de vida: la alimentación y la actividad física. La alimentación inadecuada y el sedentarismo está en el origen de muchas enfermedades crónicas.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Disminuir la prevalencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con los estilos de vida y mejorar la calidad de vida de toda la población (alimentación sana y actividad física regular). |
| **Objetivos específicos.** | . Alimentación saludable.<br>. Práctica de actividad física regular.<br>. Promoción de la socialización y establecimiento de vínculos para mejorar el estilo de vida.<br>. Intervenir con personas con sobrepeso-obesidad y riesgo de diabetes 2. |

**PROGRAMA MARCO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.**

Disfrute de una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgos / Protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Contribuir a la vivencia sana y placentera de las diversas sexualidades de las personas en la ciudad de Madrid. |
| **Objetivos específicos.** | . Sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva con perspectiva de género.<br>. Retraso diagnóstico en VIH e ITS.<br>. Acceso a métodos anticonceptivos.<br>. Asesoramiento en las vivencias de las sexualidades.<br>. Afrontamiento sobre la soledad no deseada en personas que sufrieron malestares por una mala vivencia relacionada con la salud sexual y reproductiva. |

**PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONSUMO DE TABACO.**

Reducir el impacto sociosanitario producido por el consumo de tabaco como una prioridad de salud pública.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en la ciudad de Madrid. |
| **Objetivos específicos.** | . Prevenir el inicio del consumo de tabaco entre adolescentes.<br>. Incrementar la tasa de abandono del hábito de tabaco.<br>. Motivar a las personas fumadoras que no desean dejar de fumar (fase precontemplativa).<br>. Promover hábitos saludables entre las personas en situación de soledad no deseada. |

**PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL.**

Mejorar las relaciones humanas y las condiciones de vida, por su correlación con la salud mental. Desarrollo de los recursos personales y habilidades para afrontar situaciones difíciles y construir vínculos y redes de apoyo sociales y comunitarias / Promoción de actuaciones con enfoque salutogénico.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Promocionar la salud mental y el bienestar emocional de la población madrileña y la prevención de sus principales problemas de salud mental. |
| **Objetivos específicos.** | . Establecimiento de hábitos saludables desarrollo aspectos psicológicos en los Programas Marco.<br>. Importancia de la vinculación emocional positiva y saludable para facilitar la adaptación a los distintos momentos del ciclo vital.<br>. Recursos personales y sociales para afrontar situaciones difíciles y estresantes de la vida cotidiana (situaciones de duelo).<br>. Prevención de la soledad no deseada / Fomento de relaciones basadas en el buen trato, respeto mutuo, autonomía y cooperación.<br>. Apoyo psicológico y asesoría en promoción de la salud mental a personas y profesionales. |

**PROGRAMA MARCO DE SALUD MATERNO INFANTIL.**

Importancia del contexto familiar en el desarrollo de las personas → Importancia de las competencias parentales para el buen trato infantil y la creación de apegos seguros. Es fundamental la intervención con familias en situación de vulnerabilidad por factores individuales, familiares o sociales. El programa se desarrolla en red con otros recursos formales e informales del territorio.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Favorecer maternidades y paternidades positivas que posibiliten el desarrollo adecuado del menor. |
| **Objetivos específicos.** | . Elevar el nivel de salud de madres y padres antes de la concepción, en el período prenatal y perinatal.<br>. Facilitar el vínculo afectivo entre el niño/a y la figura parental.<br>. Crianza positiva en los primeros años de vida.<br>. Atención integral en situaciones de especial vulnerabilidad / coordinación. |

**PROGRAMA MARCO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.**

Apoyo a la comunidad educativa en la prevención y promoción de la salud desde un enfoque integral y positivo, en coordinación con los recursos socio-sanitarios y educativos del distrito / utilización de espacios formales e informales para la equidad / generación de escuelas y espacios educativos promotores de la salud.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Apoyar a la comunidad educativa en la prevención y promoción de la salud física, emocional y social de la población adolescente y joven y del conjunto de la comunidad educativa. |
| **Objetivos específicos.** | . Participación activa de la comunidad escolar en la promoción de la salud.<br>. Espacios de reflexión y búsqueda de activos en salud.<br>. Apoyo a familias y profesorado en la promoción de estilos y hábitos de vida saludables.<br>. Potenciación de hábitos individuales para el cuidado de la salud.<br>. Atención individualizada.<br>. Coordinación y trabajo en equipo con otros recursos e instituciones sociosanitarias.<br>. Reducción del impacto de la soledad no deseada en niños/as y adolescentes migrantes, que hayan estado tutelados o de colectivos en riesgo de exclusión social.<br>. Práctica del ejercicio físico.<br>. Hábitos alimenticios saludables.<br>. Desarrollo de habilidades para la vida. |

**PROGRAMA MARCO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.**

Respuesta a la realidad de las personas mayores desde sus problemas de salud y sus fortalezas. El envejecimiento activo se define como la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Desarrollo de actividades preventivas y de promoción de la salud → mantenimiento de la capacidad funcional de las edades avanzadas → Desarrollo integral, bienestar, calidad de vida / Importancia del entorno, el fomento de la participación y la solidaridad intergeneracional, lucha contra la estigmatización de la población mayor.

| | |
|---|---|
| **Objetivo general.** | Contribuir a ampliar la esperanza de vida activa y saludable, mejorando la calidad de vida y disminuyendo la soledad no deseada de las personas mayores. |
| **Objetivos específicos.** | . Información y difusión.<br>. Sensibilización sobre los principales problemas de las personas mayores.<br>. Promoción de hábitos saludables, bienestar emocional y fomento del buen trato.<br>. Incremento del bienestar integral / prevención de la soledad no deseada.<br>. Inclusión y participación de las personas mayores en la vida de su comunidad.<br>. Identificación de personas en situación de alto riesgo. |

## MARCO OPERATIVO.

| | |
|---|---|
| **Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc).** | 16 centros.<br>Equipos interdisciplinares: medicina, enfermería, ginecología, trabajo social, psicología, educación social ...<br>**PROYECTOS DE CENTRO.** Se elaboran según:<br>. Necesidades de la población<br>. Necesidades detectadas en los Programas Marco<br>. Evaluaciones los anteriores proyectos de centro<br>. Recursos sociales, sanitarios y educativos del área de influencia del centro<br>. Prioridades establecidas por el equipo |
| **Centros específicos.** | . Centro de prevención del deterioro cognitivo.<br>. Centro de salud bucodental.<br>. Centro de salud internacional.<br>. Centro de especialidades médicas.<br>. Centro Joven. |
| **Centros de apoyo.** | . Centro de diagnóstico por imagen.<br>. Laboratorio de análisis clínicos.<br>. Centro de Apoyo a la Seguridad. |